検査部門間連携が抗菌薬変更に寄与した実例

◎谷藤 流空[1)]、池ヶ谷 佳寿子[1)]、府川 早樹子[1)]、塩川 一樹[1)]、須藤 淳[1)]、望月 久仁子[1)]
静岡市立清水病院[1)]

【はじめに】臨床検査は多岐にわたる専門領域で構成されており、部門ごとに業務や配置場所が異なるため、日常的な関わりが限られる場合も少なくない。しかし、検査室内においても部門間で情報共有を行い、過去の症例などから得られた知見を共有・活用することは診療支援の質向上において重要であると考えられる。今回血液検査部門と細菌検査部門の連携により、臨床への適切な情報提供に繋がった症例を経験したので報告する。

【症例】25 歳、女性。当院にて急性虫垂炎と診断され、入院のうえ保存的治療が開始された。セフメタゾール（CMZ）を 2 日間投与後、3 日目朝よりアモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム合剤（AMPC/CAV）とアモキシシリン（AMPC）内服へ変更予定となった。3 日目朝の血液検査にて異型リンパ球 12.5%を認め、血液検査部門より細菌検査部門へ異型リンパ球の出現およびペニシリン系抗菌薬の処方が予定されていることについて情報共有が行われた。過去の症例において異型リンパ球を認めた患者に対し、Epstein-Barr Virus（EBV）陽性判明前に AMPC/CVA および AMPC が処方され、その後発疹を認めた症例を経験していた。この症例を契機に、血液検査部門と細菌検査部門間で「EBV 感染患者ではペニシリン系抗菌薬の投与は発疹リスクを伴うこと」が共有されていた。今回も同様の危険性が確認されたため、細菌検査部門より主治医へ連絡し、EBV PCR 検査の実施許可および結果判明まで抗菌薬内服を保留するように依頼した。その後、EBV PCR 検査は陽性となり、処方抗菌薬はレボフロキサシン（LVFX）へ変更となった。

【考察】本症例では当初 EBV 感染は臨床的に考慮されていなかった。しかし、血液検査部門から異型リンパ球出現および処方予定薬に関する情報共有が行われたことで、EBV 感染を想起し速やかな追加検査および主治医への情報提供に繋げることができた。今回の経験から、臨床検査技師は各部門が個別に検査結果を報告するだけでなく、横断的に情報共有した上で、臨床的意義を踏まえて統合的に評価し、臨床に働きかけることが重要であると考えられた。

連絡先：054-336-1111（内線 2616）